Universidad de Alcalá

Facultad de Ciencias de la Educación

Grado en Magisterio de Educación Infantil

Trabajo de Fin de Grado

ABORDANDO EL TRAUMA INFANTIL Y SU IMPACTO EN LA EDUCACIÓN INFANTIL: ESTRATEGIAS DE APOYO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO Y FAMILIAR, INTERVENCIÓN Y ORIENTACIÓN.

Autor: Layda López Lora

Tutora: Nuria Martín Romero

2024

“"La infancia es el terreno

en el que plantamos

las semillas del futuro.”

ÍNDICE

RESUMEN. 4

I. INTRODUCCIÓN. 5

III. OBJETIVOS. 6

2.1 Objetivo general. **..... 6**

2.2 Objetivos específicos. **..... 6**

IV. METODOLOGÍA. 6

V. MARCO TEÓRICO. 6

4.1. DEFINICIÓN Y COMPRENSIÓN DEL TRAUMA. 6

4.1.1 Definición del trauma. 6

4.1.2 El Trauma infantil. 7

4.2. RELACIÓN CON LA TEORÍA DEL APEGO. 8

4.2.1 Teoría del apego. 8

4.2.2 Desarrollo de vínculos seguros e inseguros. 9

4.2.3 Explorando la dinámica del apego en situaciones traumáticas 10

4.3. ANÁLISIS DEL TRAUMA INFANTIL: FACTORES CLAVE. 11

4.3.1 Causas del trauma infantil: Factores ambientales y familiares. 11

4.3.2 Consecuencias del trauma infantil: Repercusiones a corto y largo plazo. 14

4.3.3 Impacto neurobiológico: ¿Cómo actúa el cerebro en respuesta al trauma infantil? 17

4.4. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN LA EDUCACIÓN INFANTIL 18

4.4.1 Abordando el trauma en el entorno educativo. 18

4.4.2 Rol del educador en la identificación y respuesta al trauma. 19

4.4.3 Estrategias para profesores: Fomento de un entorno de apoyo y seguridad. 21

4.4.4 Estrategias para los padres: Colaboración entre escuela y familia. 22

4.4.5 Promoción de las prácticas parentales resilientes. 23

4.5. CONCEPTUALIZACIÓN Y PRÁCTICA EDUCATIVA. 25

4.5.1 El papel del educador en la prevención, detección y la intervención. ... 25

4.5.2 Estudio de un caso: Análisis detallado de un caso real en el entorno educativo. 26

VI. CONCLUSIÓNES Y DISCUSIONES. 33

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS..... 35

VIII. ANEXOS. 46

IX. ABREVIACIONES. 55

RESUMEN.

En un contexto donde el trauma infantil es frecuente, es crucial que la comunidad educativa tome acciones para entender, abordar y mitigar su impacto en el desarrollo integral y la salud emocional de los niños. Este trabajo se centra en aumentar la conciencia sobre este tema, resaltando la importancia de la colaboración entre la escuela, la familia y otros profesionales para identificar y manejar los efectos de las situaciones traumáticas. Además, busca proporcionar al personal educativo herramientas especializadas, fortalecer las habilidades parentales, establecer entornos escolares seguros y comprensivos, e integrar técnicas de apoyo emocional en el plan de estudios para fomentar la resiliencia y el bienestar de los estudiantes.

Palabras claves: Trauma | infancia | emociones | educación | escuela | familia | desarrollo | docentes | intervención | resiliencia

ABSTRACT.

In a context where childhood trauma is common, it is crucial that the educational community takes action to understand, address and mitigate its impact on the holistic development and emotional health of children. This work focuses on raising awareness of this issue, highlighting the importance of collaboration between school, family and other professionals to identify and manage the effects of traumatic situations. It also seeks to provide educational staff with specialized tools, strengthen parenting skills, establish safe and supportive school environments, and integrate emotional support techniques into the curriculum to foster resilience and student well-being.

Keywords: Trauma | childhood | emotions | education | school | family | development | teachers | intervention | resiliency

I. INTRODUCCIÓN.

En el ámbito educativo, los docentes tienen una responsabilidad fundamental: velar por el bienestar de sus alumnos. Esta tarea, aunque pueda parecer trivial, tiene un impacto significativo en el desarrollo integral y el bienestar emocional de los estudiantes. Las escuelas son espacios donde los menores pasan gran parte de su tiempo, en ellas, los educadores intentan, en la medida de lo posible, cumplir con los objetivos de cada etapa educativa y asegurar que el proceso de aprendizaje sea beneficioso para los estudiantes y útil para su futuro. Para lograrlo, es crucial una estrecha colaboración entre la escuela, la familia y otros profesionales.

Durante la infancia, los individuos pueden experimentar momentos de tristeza que dejan una huella duradera y, en algunos casos, los acompañan toda la vida. Estas experiencias pueden surgir de diversas fuentes, como la pérdida de un familiar cercano, el acoso, o cualquier forma de daño infligido por otros. Las consecuencias de estos eventos varían según la persona y pueden afectar a su desempeño académico, así como su desarrollo emocional y social. Afortunadamente, si atravesamos momentos difíciles o delicados y contamos con una red de apoyo sólida y fuerza mental el proceso de recuperación es más sencillo. Sin embargo, ¿todos tienen esa suerte? Lamentablemente, no es así. Muchos niños que asisten a nuestras aulas llevan consigo un gran dolor interno y, por diversas razones, atraviesan este duelo emocional en soledad, sin el apoyo necesario. Al crecer, estos niños se dan cuenta de diversas situaciones que les hubiese gustado evitar en su momento. Entonces, ¿qué puedo hacer como profesor? la respuesta es clara: formarse adecuadamente. Imaginémonos un entorno escolar donde se implementen estrategias y programas específicos para prevenir e intervenir en situaciones en las que los niños experimentan experiencias potencialmente traumáticas. Por estos motivos, la formación adecuada de los docentes y la estrecha colaboración entre la escuela y la familia pueden ser herramientas poderosas para detectar, abordar y detener las consecuencias del trauma infantil. Esto permitirá a los alumnos tener un futuro más prometedor y ser más conscientes de la importancia de la salud mental.

II. OBJETIVOS.

2.1 Objetivo general.

Este trabajo busca sensibilizar sobre cómo el trauma influye en el desarrollo y la salud emocional de los niños, por este motivo el objetivo general es:

- Promover la conciencia sobre el impacto del trauma en el desarrollo integral y el bienestar emocional de los niños.

2.2 Objetivos específicos.

De la misma manera, se trabajará de forma transversal los siguientes objetivos:

- Fomentar la colaboración entre la escuela, la familia y otros profesionales en la identificación y gestión de situaciones traumáticas.
- Proporcionar información y recursos al personal educativo, así como promover prácticas parentales resilientes creando un entorno educativo seguro y comprensivo.

III. METODOLOGÍA.

La metodología de este TFG teórico sobre el trauma en la Educación Infantil incluye una revisión exhaustiva de la literatura. Se recopilaron y analizaron teorías y estudios previos de fuentes académicas relevantes, como APA PsycNet, PubMed, Google Académico, páginas oficiales del gobierno de España y recursos educativos. Utilizando criterios estrictos de inclusión y exclusión, se llevó a cabo una búsqueda sistemática, seguida de un análisis de contenido y una síntesis de la información, todo ello respetando las normas éticas y de citación académica.

IV. MARCO TEÓRICO.

4.1 DEFINICIÓN Y COMPRENSIÓN DEL TRAUMA.

4.1.1 Definición del trauma.

El trauma es una vivencia que tiene el potencial de generar un impacto profundo en la vida de las personas. Más allá de un ‘simple’ evento, las experiencias traumáticas generan fuertes emociones y reacciones físicas que

pueden persistir a lo largo de los años. La Asociación Americana de Psicología (APA) define el trauma como una respuesta emocional a un suceso terrible, como un accidente, una violación o un desastre natural. Esta definición guarda similitud con la de la Real Academia Española (RAE), que lo describe como un impacto emocional que causa un daño persistente en el inconsciente. Ambas definiciones mantienen que es un acontecimiento no deseado que el individuo experimenta de forma subjetiva, manifestando sentimientos de miedo, falta de control, impotencia o culpa.

Aunque el trauma no se considera un trastorno mental según las últimas ediciones de los principales manuales diagnósticos como es CIE-11 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), vigente desde el 1 de enero de 2022, y el DSM-5 de la Asociación Americana de Psicología (APA), publicado el 18 de mayo de 2013, su impacto no debe ser subestimado. El manejo inadecuado del trauma puede conducir al desarrollo de trastornos mentales, como la ansiedad, la depresión y el trastorno por estrés postraumático (TEPT) limitando nuestro bienestar y potencial.

4.1.2 El Trauma infantil.

Tanto niños como adultos pueden enfrentarse a situaciones traumáticas que amenazan su integridad física o mental. Aunque el cerebro goza de mucha plasticidad en la adultez, y se adapta a cualquier circunstancia, durante la infancia, existen diferentes ‘periodos sensibles’ que son críticos para el desarrollo humano y, por ende, para el aprendizaje (Blakemore y Frith, 2007).

Erik Erikson nos muestra los diferentes estadios psicosociales en *El ciclo vital completado* (1998). Expone que el desarrollo del niño se caracteriza por una serie de etapas donde cada una presenta un desafío que el niño debe superar. La resolución exitosa de cada conflicto conduce a la formación de una fortaleza psicológica, mientras que la resolución no exitosa, lleva a dificultades en el desarrollo posterior. En los estadios que explica Erikson (1998), se expone que además de abarcar diversos aspectos de la persona como son a nivel somático, psíquico y ético-social, también comprenden el conjunto de procesos

psicosexuales y psicosociales en un momento determinado de la vida de un individuo, siguiendo un principio epigenético. Este enfoque amplio y multidimensional sobre el desarrollo humano proporciona un marco teórico integral para comprender la formación de la identidad y la resolución de conflictos a lo largo de la vida, incluida la infancia.

En 1948, la OMS definió la salud como “un estado de completo bienestar físico, psicológico y social, y no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades”, reconociendo la importancia de la salud mental y el bienestar emocional. Las experiencias traumáticas pueden provocar una serie de respuestas emocionales y físicas exageradas e intensas que impactan negativamente al individuo, lo que resalta la necesidad de abordar el bienestar emocional tanto en niños como adultos. Por lo general, los adultos que experimentaron un trauma en su infancia y no recibieron la atención adecuada para sus problemas durante la niñez y adolescencia suelen ser más propensos a desarrollar trastornos en la edad adulta (Peterson, 2018). Afortunadamente, aunque los niños experimenten un evento traumático, no siempre desarrollan un trastorno mental. Su aparición depende de muchos factores como la gravedad del trauma, la reacción de los cuidadores, la cercanía del evento, el entorno y factores de protección del niño, como la familia y la comunidad. Estos elementos pueden reducir el impacto adverso del trauma (Peterson, 2018).

4.2 RELACIÓN CON LA TEORÍA DEL APEGO.

4.2.1 Teoría del apego.

Actualmente, el concepto de apego es un pilar fundamental en la psicología actual desde el siglo XX gracias a John Bowlby quien elaboro la teoría del apego entre los años 1969 y 1980 (Moneta, 2014). El apego se describe como un vínculo emocional profundo que se forma entre un individuo y otro, especialmente durante la infancia. Durante esta etapa, se forman los lazos emocionales entre el bebé y sus principales cuidadores, los cuales son fundamentales para un adecuado desarrollo emocional, social y psicológico. Según la teoría de Bowlby (1979), existe la necesidad inherente de establecer vínculos de apego con otros seres humanos. En la infancia, los niños buscan

proximidad, seguridad, protección y afecto con sus cuidadores, quienes, en general, suelen ser más fuertes o capacitados para afrontar el mundo. Este comportamiento, conocido como "comportamiento de apego", se manifiesta durante este periodo como consecuencia de la alta dependencia del individuo en esta etapa de desarrollo. Conforme el individuo madura, este comportamiento tiende a decrecer gradualmente (Bowlby, 1979).

"Se van acumulando datos demostrativos de que los seres humanos de todas las edades son más felices y pueden desarrollar mejor sus capacidades cuando piensan que tras ellos hay una o más personas dignas de confianza que acudirán en su ayuda si surgen dificultades." Bowlby, 1979, como se citó en Gerstenhaber,2001, pp. 49

4.2.2 Desarrollo de vínculos seguros e inseguros.

Para entender la relación que existe entre las experiencias traumáticas y el apego es necesario comprender los modelos o tipos de apego que existen. Gracias a Mario Marrone, en su libro *La teoría del apego. Un enfoque actual* (2009) y el libro de *El mundo del bebé* (2001) donde aparece un artículo de Claudia Gerstenhaber se recogen las siguientes posturas:

Apego seguro: Este tipo de apego se forma en una relación segura donde los cuidadores principales cumplen con las necesidades del niño y establecen un vínculo de confianza, brindando consuelo durante momentos de estrés y atendiendo sus necesidades emocionales.

Apego inseguro evitativo: Suele aparecer cuando las principales figuras de referencia no satisfacen las necesidades de cuidado o seguridad del individuo. Se desarrolla cuando el cuidador no interactúa con él bebe o no muestra afecto físico, lo que lleva al niño a resolver sus necesidades sin depender de ayuda externa.

Apego inseguro ambivalente: Este modelo combina el deseo de proximidad con el miedo al rechazo. Suele aparecer cuando sus cuidadores responden de manera impredecible a las necesidades del niño o hay excesiva critica o expectativas hacia el niño.

Apego inseguro desorganizado: Este tipo de apego surge cuando los cuidadores tienen problemas mentales severos o consumen sustancias, creando interacciones impredecibles, como en casos de maltrato donde la madre es en ocasiones afable y en otras violenta lo que genera respuestas desorganizadas en las relaciones de apego.

4.2.3 Explorando la dinámica del apego en situaciones traumáticas.

John Bowlby en *Attachment and loss: Attachment* (1969) planteó la existencia de los modelos de trabajo internos (MTI) que, si bien están estrechamente relacionados con los estilos de apego, no son lo mismo. Los estilos de apego se centran en el comportamiento y las emociones que se observan en las relaciones cercanas de un individuo incluyendo su respuesta emocional, su capacidad para confiar y su manera de manejar la intimidad. Sin embargo, los MTI son las representaciones mentales que se forman en la infancia temprana, están basadas en nuestras experiencias y fijan nuestras creencias y expectativas sobre nosotros mismos y las relaciones (Bowlby, 1969). Para entender mejor esta diferencia pondremos un ejemplo hipotético:

"El estilo de apego inseguro evitativo de una persona a nivel general tiende a desear tener relaciones cercanas, pero, por diferentes experiencias su conducta es fría y poco cercana temiendo que la relación se vuelva muy intensa y termine en desilusión. Esta conducta es causada por el miedo al rechazo o al abandono, por lo tanto, un ejemplo de modelo de trabajo interno seria: quiero cercanía, pero tengo miedo de salir lastimado. Los demás son impredecibles y pueden rechazarme".

Si bien no todas las personas con un estilo de apego tienen el mismo modelo de trabajo interno nos sirve para comprender la conexión entre los estilos de apego y los MTI. Sin embargo, ¿esta relación que influye en nuestros pensamientos y palabras puede reforzar creencias negativas arraigadas en dicho modelo? cuando las personas reflexionan sobre sus experiencias internas, como sus pensamientos, sentimientos o percepciones, tienden a describirlas utilizando palabras o lenguaje. Baars (2003) respalda esta idea, sugiriendo que la introspección y la reflexión interna tienden a manifestarse en forma verbal, lo que implica que las personas suelen narrar o etiquetar sus experiencias internas con palabras. En caso de los niños, esta capacidad de reflexión aún está en proceso

de maduración y hasta los 4 años no tienen un concepto claro de sí mismos (ni de sus pensamientos ni de sus emociones) esto se debe a que están en una etapa egocéntrica donde no llegan a reflexionar sobre sus propias acciones o comportamientos (Piaget, 1926). A pesar de ello, es crucial destacar la estrecha relación entre el lenguaje y el pensamiento. Según Vygotski (1979), el lenguaje no solo sirve para expresar el pensamiento, sino que también lo modela y organiza.

La forma en que las personas traumatizadas manejan las relaciones interpersonales depende del contenido y la naturaleza de su diálogo interno. Más allá de la relación de apego niño-cuidador, este diálogo interno es crucial en el contexto del trauma, influyendo en diversas facetas del apego. Por ejemplo, aquellos con modelos internos de apego basados en la desconfianza pueden enfrentar dificultades para establecer relaciones de apoyo durante la recuperación del trauma. Según Alderson-Day y Fernyhough (2015), el diálogo interno es fundamental para realizar funciones cognitivas como la planificación y el control emocional, destacando su importancia en la prevención de déficits en la autorregulación emocional. En el artículo de Alderson-Day y Fernyhough (2015), se cita un estudio realizado por D'Argembeau (2011) donde demostró que el habla interna tiene un peso emocional similar al dialogo externo, afectando la salud física y psicológica.

4.3 ANÁLISIS DEL TRAUMA INFANTIL: FACTORES CLAVE.

4.3.1 Causas del trauma infantil: Factores ambientales y familiares.

El trauma infantil puede tener un impacto negativo en el desarrollo físico, emocional y social del niño. Este trauma se origina a partir de sucesos que superan la capacidad del individuo para gestionar sus emociones. Explorar estos factores es esencial para entender su influencia e intentar mitigar su impacto en el desarrollo. Aun así, es importante reconocer que no todos los niños que atraviesan experiencias traumáticas sufren las mismas consecuencias negativas.

Según "*The National Child Traumatic Stress Network*" (NCTSN) (2018), se consideran experiencias traumáticas los siguientes factores:

En cuanto a **factores familiares** encontramos:

Abuso físico, sexual o psicológico, y negligencia (incluida la trata): Los abusos infantiles y las negligencias son dos tipos de maltrato infantil. El abuso sexual implica la manipulación del niño para la gratificación sexual del agresor ya sea perpetrado por individuos conocidos o extraños (Berlinerblau, 2017) mientras que el abuso físico se centra en causar lesiones, como golpes y quemaduras. Normalmente este tipo de abusos van acompañado del maltrato emocional, que implica acciones no físicas por parte del cuidador hacia el niño, poniéndolo en riesgo de sufrir daño emocional (Kimber y MacMillan, 2017). La negligencia, sin embargo, es la falta de cuidado y atención hacia el niño, manifestada en la privación de cuidados parentales básicos como la desnutrición, vulnerando así sus derechos fundamentales (Healthy Children.Org;2022).

Pérdida repentina o violenta de un ser querido: Se trata de un duelo traumático que pueden sufrir los niños cuando sus figuras de apego cercanas mueren de una forma inesperada. Provoca un sentimiento de dolor y puede llegar a manifestar una inestabilidad mental o emocional. Se puede dar en situaciones como asesinato, suicidios, enfermedades o accidentes (Griffin, 2018).

Separación traumática y divorcios (incluida la inmigración o encarcelamiento): La administración del Gobierno de España explica en “Separación y divorcio” que el divorcio es una extinción del vínculo matrimonial, sin embargo, cuando hablamos de separación traumática se enfoca en el vínculo del individuo con personas cercanas que, por razones de muerte, abandono, encarcelamiento, guerras o forzosas migraciones, la relación se interrumpe abruptamente.

Violencia familiar: La violencia familiar según el ministerio de sanidad y consumo (2003) se define como el conjunto de acciones de maltrato o agresiones físicas, psicológicas, sexuales u otras formas de violencia, perpetradas por individuos dentro del entorno familiar y dirigidas principalmente hacia los miembros más vulnerables, como niños, mujeres y ancianos.

Pasando a los **factores ambientales** podemos encontrar:

Desastres naturales y tecnológicos: Según el artículo "Desastres naturales y tecnológicos" de Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico los desastres naturales son eventos causados por procesos terrestres como terremotos y huracanes, mientras que los desastres tecnológicos son consecuencia de la negligencia humana, como accidentes industriales y fugas nucleares.

Terrorismo, violencia masiva: La Interpol en su apartado “Terrorismo” define el terrorismo como una red compleja que utiliza la violencia para alcanzar objetivos políticos o religiosos extremos, a menudo mediante materiales QBRNE (químicos, biológicos, radiactivos, nucleares y explosivos). La violencia masiva hace referencia a los actos premeditados, como tiroteos o genocidios que pueden causar la muerte de un gran número de personas.

Discriminación raciales o prejuicios: En el folleto de “¿Qué es la discriminación racial?” de la UNODC define la discriminación como aquella distinción, exclusión, restricción o preferencia que, basada en la raza, el color, la ascendencia o el origen nacional o étnico busque impedir o reducir el reconocimiento, disfrute o ejercicio equitativo de los derechos humanos y libertades fundamentales.

Accidentes graves o enfermedades potencialmente mortales: Nos referimos a los eventos donde el individuo o una persona cercana al individuo sufre una enfermedad o accidente que tiene un alto riego de causar la muerte o un daño significativo a la salud como pueden ser accidentes de tráfico, quemaduras...etc.

4.3.2 Consecuencias del trauma infantil: Repercusiones a corto y largo plazo.

El Informe FAROS, titulado *Los problemas de salud infantil. Tendencias en los países desarrollados* (2008) examina, entre otros, la evolución de los problemas de salud infantil en los países más desarrollados. El informe destaca que, entre las diversas enfermedades que afectan a la población de 0 a 15 años, la salud mental es una de las principales preocupaciones para políticos y profesionales de la salud. Según las encuestas realizadas en este estudio, el 22,1% de los niños y adolescentes de entre 4 y 15 años corre el riesgo de sufrir un deterioro en su salud mental (Álvarez et al., 2008). A su vez, estudios anteriores a este, ya indicaban que en España entre el 12% y el 24% de la población infantil tenía una incidencia frecuente hacia las patologías neuropsiquiátricas (Matey, 2001). Según cita Matey en su artículo "Muchos niños para el diván", la OMS en 2020 advirtió de que estos trastornos pueden llegar a ser una de las cinco causas más comunes de morbilidad o incapacidad en la población infanto-juvenil y, aun así, actualmente, en promedio los países desarrollados dedican menos del 2% de sus presupuestos a la atención de la salud mental (Matey, 2001; OMS, 2022).

Según el estudio que realizó FAROS (2008), los trastornos mentales infantiles y los eventos traumáticos están relacionados. Los niños que sufren traumas pueden desarrollar problemas de conducta, baja atención, dificultades para dormir, irritabilidad y altos niveles de estrés. Tanto el estudio de FAROS (2008) como el artículo "*PTSD Basics*" de *U.S. Department of Veterans Affairs* se destacan los siguientes síntomas a corto plazo:

Síntomas emocionales:

<u>Dependencia emocional</u>: La persona puede sentir una necesidad excesiva de apoyo o compañía, buscando constantemente la aprobación o el afecto de los demás.

<u>Nerviosismo e inquietud</u>: Se observa un estado de tensión constante, con irritabilidad, dificultad para concentrarse y una sensación de estar siempre en alerta.

Llanto frecuente: Experimenta episodios de llanto sin causa aparente, incluso ante situaciones cotidianas que antes no generaban este tipo de respuesta.

Tristeza persistente: Un estado de ánimo deprimido o melancólico que se prolonga en el tiempo, afectando el disfrute de actividades que antes eran agradables.

Sintomatologías físicas frecuente:

Dolor de cabeza: Se puede llegar a sufrir dolores de cabeza frecuentes, especialmente en situaciones de estrés o ansiedad, lo que impacta negativamente en la calidad de vida.

Náuseas: Sufre malestar estomacal y náuseas en momentos de ansiedad, afectando su alimentación y capacidad para disfrutar de las comidas.

Sintomatología en base a conductas disruptivas:

Hiperactividad: Presenta un nivel de actividad excesivamente elevado y dificultad para estar quieto o concentrado, lo que interfiere con el aprendizaje, las actividades diarias y las relaciones interpersonales.

Problemas de conducta: Los niños traumatizados suelen tener dificultades en las relaciones con sus pares, debido a comportamientos agresivos o impulsivos. Manifiestan comportamientos disruptivos o desafiantes como una forma de expresar su malestar emocional

Conductas asociales o ansiosas: Se muestra retraído y evita situaciones sociales por ansiedad o incomodidad, lo que limita las oportunidades de interacción y afecta el desarrollo de habilidades sociales.

Anton Barry, presidente de la APA, explica en *"Rebounding from Trauma"* (2015) que las consecuencias de los traumas pueden afectar diversos ámbitos a largo plazo y manifestarse en la vida adulta:

Repercusiones negativas físicas: El trauma puede causar enfermedades crónicas cardíacas, pulmonares y hepáticas. El estrés crónico que se genera daña el sistema cardiovascular, afecta el sueño (Rutledge, 2022), disminuye el sistema inmunológico aumentando la susceptibilidad a infecciones respiratorias (Lopes et al., 2020), y eleva el cortisol, lo que puede llevar a comportamientos de riesgo como el consumo excesivo de alcohol, dañando el hígado (Brady y Back, 2012).

Repercusiones negativas psicológicas: Las conductas de salud negativas debido al trauma pueden conducir al consumo de tabaco, que aumenta el riesgo de enfermedades cardiacas, pulmonares y cáncer (Roberts et al., 2008), así como enfermedades de transmisión sexual, ya que hay una asociación entre diversos traumas infantiles y conductas sexuales de riesgo (London et al., 2017). Además, puede contribuir a la obesidad grave debido a diferentes factores ambientales (NICHD, 2021) así como puede dar lugar a trastornos mentales.

Repercusiones en el funcionamiento social y ocupacional: El trauma infantil, puede afectar negativamente al rendimiento de las personas y la interacción con los demás. La exposición prolongada al trauma puede derivar a tener problemas relacionales por tener dificultad para confiar y comunicarse con los demás o autorregular las emociones. Este tipo de conductas dificultan que el individuo pueda disfrutar de la vida y alcanzar sus metas.

Repercusiones en el ámbito académico: El estudio ACE de Felitti (Experiencias Infantiles Adversas), mencionado en *El cuerpo lleva la cuenta: Cerebro, mente y cuerpo en la superación del trauma* de Bessel Van Der Kolk (2015), revela que el trauma infantil afecta significativamente el entorno escolar. Se relaciona con problemas de atención, memoria y procesamiento de información, lo que puede resultar en bajas calificaciones, falta de motivación y, en casos graves, abandono escolar. En la vida adulta, el impacto del trauma se refleja en problemas como el ausentismo laboral, ingresos reducidos y dificultades financieras.

4.3.3 Impacto neurobiológico: ¿Cómo actúa el cerebro en respuesta al trauma infantil?

La historia de Noam, un niño de 5 años que presenció los ataques del 11 de septiembre de 2001 en *El cuerpo lleva la cuenta: Cerebro, mente y cuerpo en la superación del trauma* de Bessel Van Der Kolk (2015), destaca la respuesta adaptativa del cerebro ante el trauma.

"una vez que alcanzó la seguridad de su hogar, las alarmas de su cerebro y su cuerpo se apagaron, lo cual le permitió liberar su mente para comprender qué había sucedido e incluso imaginar una alternativa creativa a lo que había visto, una cama elástica para salvar vidas" Van Der Kolk, 2015, p. 71

Mientras Noam pudo procesar los eventos traumáticos gracias a su entorno de apoyo, muchos niños enfrentan dificultades para adaptarse a situaciones similares. Cuando el cerebro activa la respuesta de "alarma", incluso de forma inconsciente, prioriza necesidades básicas como alimentación, descanso y protección de forma instintiva, desencadenando acciones de huida, escondite o lucha. Si la respuesta no es efectiva y no se restaura el equilibrio, el cuerpo permanece en estado de alerta, lo que hace que el sistema nervioso enfoque la energía en controlar las respuestas fisiológicas y active mecanismos de supervivencia. Esto incluye que se active el cerebro reptiliano para respuestas instintivas de "lucha o huida", la amígdala para detectar amenazas y el hipocampo para formar memorias, coordinando así la acción del cuerpo (Van Der Kolk, 2015).

En el mismo libro de Van Der Kolk (2015) se cita el caso de Stan y Ute, una pareja que presenció uno de los mayores accidentes en Canadá. En este caso, se analiza cómo la pareja experimenta momentos de disociación, fragmentación emocional, rememoración y *flashbacks*, fenómenos que alteran en el funcionamiento de la corteza prefrontal. Esta región cerebral es responsable de funciones cognitivas superiores, como la planificación, la toma de decisiones y el control del comportamiento (Van Der Kolk, 2015). Los eventos traumáticos pueden impactar la capacidad de vivir el presente y la formación de recuerdos significativos debido a la activación del sistema de respuesta al estrés. Si el trauma no se resuelve, el estrés continúa circulando por el cuerpo, generando

movimientos defensivos y respuestas emocionales repetitivas, con implicaciones en cambios neurobiológicos estructurales y funcionales (Van Der Kolk, 2015).

El trauma puede afectar al desarrollo de los sistemas de integración sensorial del cerebro, generando estrés crónico en casos como el maltrato infantil, lo que dificulta al niño distinguir entre ambientes seguros y no seguros (Van Der Kolk, 2015). Esto afecta al desarrollo cerebral y la salud física, acelerando el envejecimiento y el acortamiento prematuro de los telómeros (Coronado, 2018). Además, este estrés prolongado puede provocar anomalías en las conexiones neuronales y en la organización de las áreas cerebrales responsables de la integración sensorial resultando en un procesamiento sensorial deficiente y afectando la regulación del tálamo. Estas disfunciones pueden causar trastornos del aprendizaje, caracterizados por conexiones deficientes entre los sistemas auditivos y del lenguaje, así como una coordinación subóptima entre la función visual y motora de las manos (Van Der Kolk, 2015).

4.4 ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN LA EDUCACIÓN INFANTIL

4.4.1 Abordando el trauma en el entorno educativo.

A pesar de que la Educación Infantil es de carácter voluntario según lo estipulado por la Comunidad de Madrid continúa siendo un punto de acogida significativo por los contextos sociodemográficos y económicos que sufre el país. De acuerdo con datos actualizados de EDUCAbase (2022), en la Comunidad de Madrid se registra una matrícula de 257.846 niños en la etapa educativa de educación infantil, contribuyendo así a un total de 1.621.833 niños matriculados en toda España. Esto refleja una tasa neta de escolarización desde los 3 años del 97,2% en España (Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2022). El sistema educativo español, está regulado por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE) (Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2023). Aunque la Educación Infantil es de carácter voluntario según la ley, esta etapa se centra en establecer los cimientos cognitivos y socioemocionales que influirán en el futuro académico y personal de los niños.

Según el Ministerio de Sanidad, en 2017, los niños entre los 4-9 años tienen un riesgo de mala salud mental del 14,20% cuyo dato refleja la probabilidad de que un niño o niña experimente un trastorno de salud mental durante su infancia. De acuerdo con los principios pedagógicos establecidos en la Ley Orgánica 3/2020, artículo 19, por el Boletín Oficial del Estado (BOE, 2020), se resalta que el rendimiento escolar no solo debe reducir las desigualdades educativas, sino que también debe desempeñar un buen desarrollo socioemocional de los estudiantes para promover valores que potencien un aprendizaje más positivo y equilibrado. Mediante la capacitación del personal, la promoción de un entorno positivo y la implementación de programas de prevención, la educación infantil se convierte en un pilar fundamental para fomentar la resiliencia en los niños.

4.4.2 Rol del educador en la identificación y respuesta al trauma.

Algunas organizaciones internacionales como la UNESCO (2014) o la ONU (1948) enfatizan en la importancia de que la escuela proporcione un entorno seguro y favorable para el aprendizaje, lo cual resulta fundamental para el éxito del proceso educativo tanto para docentes como estudiantes.

En el contexto escolar, la seguridad y el apoyo son pilares fundamentales para el aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, para aquellos que han experimentado traumas, el papel de los docentes adquiere aún más relevancia. Estos niños pueden desarrollar un vínculo especial con los profesores y convertirse en una figura de confianza y apoyo. Esta conexión se forma a través de la interacción diaria del niño-profesor por las actividades y juegos que se dan en la escuela. Lamentablemente, es frecuente que los niños repriman sus emociones o eviten comunicar lo que están experimentando debido al temor a posibles consecuencias o castigos. Dado que los niños pequeños no pueden expresar verbalmente lo que les sucede, el profesor debe observar atentamente su comportamiento y desempeño, que generalmente se manifestará en conductas desafiantes y apáticas (Van Der Kolk, 2015).

En el manual de Escuelas Amigas de la Infancia creado por UNICEF (2009) para crear un entorno escolar seguro, sano y protector se ha elaborado una tabla de

ítems donde presenta mediante una serie de estrategias e intervenciones escolares que debe hacer el docente en caso de violencia sexual, intimidación y traumas inducidos por emergencias o conflictos. En resumidas cuentas, se estipula que el docente y la organización encargada, en este caso la escuela, deberá tener presente que para abordar el trauma será esencial dominar técnicas de regulación emocional para brindar el apoyo y manejo necesario para no agravar la situación. Según Van Der Kolk (2015), una de las fuentes más importantes para abordar el trauma infantil es la forma en la que nos comunicamos y qué metodología empleamos para relacionarnos con los niños. Si se utiliza una metodología autoritaria basada en castigos, esto puede generar que se cree un ambiente inseguro y convertirse en desencadenantes adicionales de trauma. Aunque estas prácticas pueden detener temporalmente un comportamiento no deseado, el sistema de alerta y las respuestas hormonales al estrés continúan activas, lo que indica que es probable que el este comportamiento se repita ante la próxima situación estresante. Por el contrario, si se adopta una metodología positiva, donde las palabras y el comportamiento no verbal transmiten un mensaje tranquilo, calmado y confiable, se puede ofrecer un entorno seguro para los niños y ayudar a mitigar el impacto del trauma en su desarrollo (Van Der Kolk, 2015).

Incorporando los hallazgos de estudios como los de Albert Mehrabian (1967), que resaltan la importancia del tono de voz y el lenguaje corporal en la comunicación emocional, junto con las experiencias de Van Der Kolk (2015) sobre la necesidad de una comunicación comprensiva y empática, se subraya la relevancia de que los maestros empleen estrategias de comunicación sensibles y empáticas, ya que los niños que han sufrido algún tipo de violencia pueden interpretar negativamente los cambios en las expresiones faciales o en el tonos de voz, lo que puede llevar a reacciones exageradas y dificultades para relacionarse en la escuela. Esta metodología busca proporcionar a los niños un espacio seguro donde puedan expresarse libremente, identificar sus emociones y aprender a comunicarse de manera efectiva. Además, al promover una relación de confianza entre el niño y el adulto, se facilita su recuperación emocional y su capacidad para superar el trauma (Van Der Kolk, 2015). Por ejemplo, en vez de presionar al niño para que participe en una actividad, el maestro podría decir:

"Parece que te sientes incómodo. ¿Hay algo que te esté preocupando? ¿Cómo puedo ayudarte a sentirte más cómodo?". De esta manera, los niños aprenden a identificar y comunicar sus emociones de manera saludable, obteniendo un sentido de control sobre su experiencia emocional y fomentando una relación de confianza con el adulto, lo que es crucial para su recuperación emocional.

4.4.3 Estrategias para profesores: Fomento de un entorno de apoyo y seguridad.

En el ámbito educativo, la creación de un entorno seguro es fundamental para garantizar el bienestar y el rendimiento académico de los estudiantes, pero, esta necesidad es más relevante cuando se trata de alumnos que han experimentado o están experimentando algún tipo de trauma. Algunas estrategias que podemos implementar en el aula son las siguientes:

Sensibilidad frente al trauma: La sensibilización de docentes y profesionales escolares es crucial para comprender y abordar los efectos del trauma en los niños. El sólido entendimiento y apoyo son fundamentales para mitigar sus impactos (Helping Traumatized Children, 2019).

Estructuración y rutinas predecibles: Las personas que han experimentado trauma suelen estar en un estado de alerta o hipervigilancia. Por tanto, cualquier cambio en la rutina o la estructura horaria puede ser percibido como una amenaza llevándolos a reaccionar de manera exagerada (Van Der Kolk, 2015). Es esencial comunicar los cambios en el horario de manera clara y asertiva.

Metodologías de enseñanza colaborativas al trauma: Los niños afectados por un trauma requieren un considerable respaldo emocional. Por ende, la enseñanza debe ser práctica, centrada en fortalezas, y utilizar metodologías como el aprendizaje experiencial y la enseñanza explícita para ofrecer retroalimentación positiva. Para implementarlo en tu aula, puedes:

- Construir relaciones de confianza: Para lograr una comunicación abierta y colaborativa será necesario establecer lazos saludables tanto con el docente como con sus iguales cuyas interacciones serán respetuosas y asertivas.

- Espacios de calma y cuidado emocional: El rincón de la calma es un área designada a promover el bienestar emocional. Estos espacios seguros servirán para la autorregulación las emociones y promoverán el conocimiento de sí mismos haciendo que la practica educativa sea más eficiente.

4.4.4 Estrategias para los padres: Colaboración entre escuela y familia.

Durante la infancia, la familia representa nuestro círculo más próximo al nacer y sin duda desempeña un papel fundamental en la transmisión de valores y expectativas. Sin embargo, a medida que crecemos y nos integramos en la sociedad, la escuela se convierte en una "microsociedad" en la que aprendemos a interactuar y desenvolvernos con diferentes personas. En la actualidad, las familias enfrentan crecientes desafíos, desde preocupaciones financieras hasta tensiones emocionales y culturales, lo que puede incidir en la crianza y generar vulnerabilidades. Por estos motivos, la escuela debe brindar apoyo y sensibilidad a las familias que necesitan ayuda, creando un entorno que comprenda sus particularidades. En situaciones donde la familia ha atravesado un evento traumático (que no involucre una mala praxis hacia el menor, como abusos o negligencias) una comunicación efectiva será fundamental para adecuarse a las necesidades individuales del alumno.

En el plan de "Las relaciones entre familia y escuela. Experiencias y buenas prácticas" del catálogo de publicaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2015) nos ofrece una visión general que destaca la importancia de una buena relación entre la familia - escuela, permitiendo a la escuela actuar de manera efectiva ante problemas o vulnerabilidades en el niño. Destacamos:

Comunicación abierta y constante: La colaboración entre la escuela y la familia es esencial para identificar de manera efectiva los problemas y consecuencias que puedan estar afectando al estudiante. La comunicación debe adaptarse a las necesidades familiares, facilitando así la transmisión regular de información sobre el progreso académico, el comportamiento y el estado emocional del alumno. Siguiendo este enfoque, permitirá la elaboración de un plan de acción integral que aborde y promueva el desarrollo completo del estudiante.

Colaboración con otros profesionales de la salud: En muchas instituciones educativas, la asistencia psicológica no forma parte de los servicios ofrecidos, lo que significa que los estudiantes que enfrentan traumas o necesidades emocionales especiales no pueden acceder directamente a la asistencia desde la escuela. Para las familias, que, en ocasiones, carecen de la información necesaria sobre cómo abordar situaciones traumáticas, resultará crucial proporcionarles acceso a recursos e información sobre los servicios disponibles en la comunidad o el vecindario.

Implementación de estrategias de apoyo emocional y recursos: Tanto las instituciones educativas como los educadores deben estar al corriente de los avances contemporáneos destinados a mejorar la calidad educativa, incluyendo técnicas de resolución de conflictos, herramientas digitales y otros recursos relevantes para alcanzar los principios generales de la ley. Proporcionar y desarrollar materiales dedicados a la gestión emocional fomentará un desarrollo emocional saludable entre los estudiantes.

4.4.5 Promoción de las prácticas parentales resilientes.

La Asociación Americana de Psicología, define la resiliencia como la capacidad que tiene un individuo para afrontar los problemas de manera afectiva y positiva ante situaciones adversas como traumas, tragedias o amenazas (APA,2011). Todos los seres humanos poseemos esta habilidad de forma innata, aunque su grado de desarrollo puede variar dependiendo de las experiencias del individuo.

El estudio de la resiliencia tras los atentados del 11 de marzo destacó que la capacidad de afrontamiento activo al trauma dependía de la propia persona y sus recursos, como la red de apoyo y la actitud (Benito, et al., 2010). Otros autores, como Bowlby en la teoría del apego (1969) y Sroufe (2007), subrayan la importancia del apego seguro en la infancia para fomentar la resiliencia. Este vínculo, permite a los niños desarrollar una base emocional sólida, esencial para enfrentar y superar adversidades a lo largo de su vida. Por estos motivos, es necesario que el adulto cuidador supere sus heridas emocionales para no afectar negativamente en la capacidad de cuidado y educación.

Las entidades como la escuela, la comunidad y la familia que mantengan contacto con menores deben asegurar su protección ya que son entornos fundamentales para el desarrollo integral de los niños. En “Potenciación de pautas parentales resilientes de familias con hijos adolescentes” (2008) y en “Guía de resiliencia: para padres y maestros” (2010) se concluye que para promover el bienestar y resiliencia en los niños es crucial enseñar:

Fomentar habilidades sociales: En la infancia es esencial demostrar afecto y más en casos de especial vulnerabilidad, de esta manera la persona será capaz de establecer una buena red de apoyo en el futuro y empatizar con los demás.

Generar confianza: Basada en el cultivo de un vínculo positivo con el niño, busca impulsar su autonomía en la consecución de metas, con el propósito de promover una autoestima positiva y fortalecer su confianza en la resolución de problemas.

Comunicación asertiva: Necesaria para que, durante estos eventos traumáticos, el cuidador establezca conversaciones claras y ordenadas adecuadas para su edad.

Promover el autoconocimiento: El niño debe ser capaz de conocerse y aprender durante el proceso. Por estos motivos, los cuidadores deberán acompañarlo siempre y cuando la guía no sea invasiva ni restrictiva.

Mantener rutinas de descanso saludables: Para los niños pequeños, las rutinas representan un símbolo de seguridad y estabilidad. Complementar estas rutinas con momentos de descanso para mitigar el estrés proporciona un respaldo adicional que contribuye positivamente a su desarrollo.

Ser flexible e innovador: Es imprescindible mejorar su visión desde un punto de vista creativo y positivo. Ayudará a adaptarse a los cambios y desarrollar fortaleza.

4.5 CONCEPTUALIZACIÓN Y PRÁCTICA EDUCATIVA.

4.5.1 El papel del educador en la prevención, detección y la intervención.

Existen diversas razones por las cuales las escuelas y los educadores deben participar activamente en la detección, notificación, intervención y prevención del trauma. Desde una perspectiva legal, hay contextos como el maltrato infantil o problemas de convivencia que están intrínsecamente relacionados con el trauma y se alinean con los objetivos respaldados por la ley, tal como se establece en el artículo 124, apartado 5, en las modificaciones de la Ley Orgánica 3/2020.

La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, en su artículo 34 expone la obligatoriedad a los centros educativos a implementar protocolos de actuación para abordar la violencia. Estos protocolos, se activan cuando el personal educativo al detectar signos de alerta o reportes de los menores, involucran sectores sanitarios, de seguridad y judiciales. Por otro lado, en el artículo 5 de la misma ley requiere que las administraciones públicas proporcionen formación especializada en derechos de la infancia a profesionales que trabajen con menores, abarcando prevención de violencia, seguridad en Internet y educación inclusiva. La prevención en entornos educativos implica que los docentes tomen medidas para evitar el trauma, como crear un entorno seguro, implementar programas de educación emocional como *"Think Equal*" y fomentar el autocuidado y la resiliencia para manejar el estrés en situaciones adversas. Es responsabilidad del docente promover una educación de calidad, basada en la ley y en las necesidades del alumnado.

Los educadores aparte de prevenir deben detectar y notificar cualquier tipo de violencia o negligencia en el aula. La mayoría de los casos de violencia se detectan en edad escolar, subrayando la importancia de la intervención educativa (Cawson et al., 2000). A lo largo de la carrera, es común que los docentes se enfrenten a situaciones donde los niños son víctimas de circunstancias difíciles en el ámbito familiar, como divorcios conflictivos, duelos, violencia intrafamiliar o negligencias. Según Eurydice (2023), la observación es

clave para identificar problemas en los niños y comenzar el proceso de detección. Utilizando ítems adaptados a diversos contextos y realizando entrevistas con familiares y el equipo educativo, se facilita la apertura de un protocolo de actuación y la comunicación al equipo directivo y orientadores.

Después de evaluar y detectar el problema, se inicia la fase de intervención, durante la cual el docente compartirá la información recopilada en el aula con las entidades correspondientes. Esto puede implicar derivar a profesionales especializados o informar al equipo educativo, incluida la coordinadora de bienestar y protección. Esta última, cuya labor fue aprobado en la Ley Orgánica 3/2020 (Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2022), tiene la responsabilidad de detectar e intervenir en situaciones de riesgo, como el acoso escolar o el suicidio, entre otras. Es esencial destacar que, desde el punto de vista legal, la protección de la infancia no debe ser influenciada por consideraciones culturales. Prácticas como la mutilación femenina, el matrimonio infantil o imposiciones religiosas no deben ser justificadas ni toleradas. En este sentido, todos los profesionales que forman parte de entidades educativas están obligados tanto ética como legalmente a intervenir en casos de maltrato, violencia u otros abusos, sin importar su origen cultural. Es fundamental reconocer que estos actos representan una clara violación de los derechos fundamentales del niño y pueden tener un impacto significativo en su bienestar emocional y general.

4.5.2 Estudio de un caso: Análisis detallado de un caso real en el entorno educativo.

A continuación, se presenta un caso real derivado de mi experiencia en prácticas. Con el objetivo de salvaguardar la privacidad y seguridad de la información personal, de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), describiré el caso de forma general utilizando seudónimos y manteniendo la confidencialidad de la identidad del niño para proteger su privacidad. Para explicar mi caso y explicar el porqué de las conductas me he basado en el libro *El chico al que criaron como un perro: Y otras historias del cuaderno de un psiquiatra infantil*

(2017) de Bruce Perry catedrático emérito de la *Child Trauma Academy* y Maia Szalavitz periodista especializada en campos de adicción y neurociencia.

"Alejandro, un niño de 5 años, manifiesta ataques de ira y conducta disruptiva en la escuela, mostrando agresividad hacia sus compañeros y objetos. Presenta dificultades para socializar y falta de interés en las actividades escolares. La profesora, Clara, ha intentado abordar su conducta desde muchos enfoques pedagógicos, pero la conductista para ella es la más acertada por el contexto del aula en el que se desenvuelve. A través de la interacción con la profesora, Alejandro ha revelado situaciones de violencia doméstica, expresando que alguien en su entorno familiar le causa daño físico y emocional. Además de los problemas de comportamiento en la escuela, se observa que Alejandro muestra signos de ansiedad y retraimiento en el aula. También se ha observado que tiene dificultades para concentrarse en las tareas escolares y muestra un bajo rendimiento académico. Fuera del entorno escolar, se sabe que Alejandro vive en un ambiente familiar marcado por la violencia doméstica, lo que podría contribuir a sus dificultades emocionales y conductuales. Su madre, Ana, ha informado a la profesora sobre episodios de violencia física y verbal por parte de su pareja, el padrastro de Alejandro, aunque no ha tomado medidas legales para proteger a su hijo debido al temor a represalias. Clara, en ausencia de recursos suficientes para abordar el tema recurrió a otros profesionales de la escuela sin éxito."

Para abordar el caso de Alejandro, es crucial adoptar un enfoque holístico que considere tanto sus necesidades emocionales como académicas. Los niños traumatizados pueden tener dificultades para absorber nuevos conocimientos y requieren un entorno de apoyo. Es comprensible que algunos profesores, como Clara, carezcan de formación específica para abordar casos de trauma en el ámbito escolar, dado que este tipo de capacitación no suele estar incluida en el currículo estándar de formación docente. Sin embargo, es importante reconocer que, dadas las circunstancias actuales, es crucial que los profesionales que traten con menores como los profesores, se preparen para adaptarse a las nuevas necesidades de la sociedad. Para entenderlo, nos podemos basar en las repercusiones emocionales que dejó la pandemia de COVID-19 en la población,

en particular en los jóvenes. Debido al prolongado periodo de confinamiento y distanciamiento social al que se han visto expuestos los niños durante su etapa sensible, ha habido un aumento significativo en la demanda de atención psicológica estos últimos años. En el artículo “La nueva pandemia psicológica” (2021) se cita a Discombe y Lennon (2020) (2021) quienes estimaron que, en 2020, las consultas de niños y jóvenes aumentarían en un 60%, mientras que la atención a niños con dificultades de aprendizaje y necesidades complejas incrementaría en un 10% (Shvets, 2021).

La situación de Alejandro plantea diversos aspectos que requieren una reflexión profunda sobre lo ocurrido. En primer lugar, es fundamental considerar la metodología utilizada para abordar este tipo de trauma en el entorno educativo. La intervención conductista, si bien se centra en modificar la conducta observable, puede no ser la más adecuada para abordar las causas subyacentes del problema, ya que no aborda de manera integral las necesidades emocionales y psicológicas del niño. En lugar de ello, se sugiere adoptar enfoques más pedagógicos que promuevan la seguridad, la autoexpresión y el bienestar emocional de los estudiantes. Por ejemplo, el aprendizaje social y emocional (SEL) se enfoca en desarrollar habilidades socioemocionales, como el desarrollo emocional, el autoconcepto y la competencia social. Esto podría ayudar a Alejandro a regular sus emociones y establecer relaciones saludables. Asimismo, el enfoque centrado en el alumno reconoce la importancia de adaptarse a las necesidades individuales de cada estudiante, permitiéndoles participar activamente en su proceso de aprendizaje y expresar sus intereses, preocupaciones y experiencias personales. La creación de un entorno de apoyo donde Alejandro se sienta escuchado y comprendido puede contribuir a reducir su ansiedad y retraimiento en el aula, lo que a su vez puede mejorar su rendimiento académico. Por último, el aprendizaje cooperativo también puede ser beneficioso para Alejandro, a pesar de su comportamiento irascible con otros niños, esta metodología le brindaría la oportunidad de trabajar en equipo y aprender habilidades sociales importantes.

Para abordar las necesidades emocionales de Alejandro, es necesario saber la importancia del lenguaje tanto verbal como no verbal. Se sabe que el profesor

es una figura importante en el aula y que los conflictos en el aula se pueden convertir en oportunidades para promover la acción tutorial. Lo que implica que los alumnos tengan actitudes de tolerancia, cooperación y colaboración (Pantoja, 2005). Para negociar, Clara utilizaba en muchas ocasiones una negociación competitiva, basada en el posicionamiento personal *"te voy a castigar si no haces lo que te digo", "como sigas así no vas a participar en la próxima actividad" o "te voy a llevar a la clase de 3 años*" a pesar de que el uso de este lenguaje ponía un límite a Alejandro no solía funcionar pues el tono de amenaza e intimidación no era el más acertado para trabajar las necesidades emocionales del mismo (Pantoja, 2005). Una persona que ha sufrido algún tipo de maltrato se encuentra en la necesidad de sobre analizar su entorno para evitar peligros y experimenta pérdida de control, impotencia y emociones negativas intensas, como Alejandro (Perry y Szalavitz, 2017). En situaciones de trauma, las emociones negativas suelen tener un impacto más profundo que las positivas, ya que están asociadas con experiencias que nuestro cerebro identifica como amenazantes para nuestra seguridad. Estas experiencias pueden incluir que los gritos, gestos o posturas dominantes generen estrés. Cuando el cerebro de Alejandro percibe estos signos en un entorno que considera "seguro", desencadena una respuesta de alerta debido a la comparación con patrones almacenados previamente (Perry y Szalavitz, 2017). Para calmar a Alejandro y establecer límites, es necesario evitar la confrontación, ya que un tono confrontativo y la descalificación pueden aumentar la tensión emocional y provocar una escalada del conflicto. Esto puede llevar a que Alejandro se oponga a lo indicado por la profesora y genere resentimiento.

Pantoja (2005) cita el informe de Delors (1996), destacando cuatro pilares para tratar conflictos: aprender a conocer, hacer, vivir juntos y ser. Estas pautas promueven el diálogo constructivo, desarrollan habilidades sociales y fomentan la autonomía y creatividad. De esta manera se evitan tonos elevados permitiendo que Alejandro pueda comunicarse de manera más efectiva y resolver las diferencias de manera pacífica. Si la profesora Clara se muestra enfadada o frustrada hay más probabilidad de que Alejandro se porte peor como un reflejo de la emoción intensa de la profesora. Por lo tanto, Clara deberá comprender que, para tranquilizar a Alejandro, primero debe tranquilizarse a sí misma.

Reconocer la influencia de las relaciones y las señales relacionales es fundamental para lograr una intervención terapéutica eficaz, así como para cualquier otra actividad humana efectiva, como la crianza, la enseñanza y el cuidado (Perry y Szalavitz, 2017).

Conocer el lenguaje no verbal es esencial para los docentes, ya que revela el estado emocional del alumno. Además, es necesario ser consciente de nuestros gestos y posturas, ya que estos afectan significativamente la percepción del interlocutor, lo cual es crucial para transmitir un mensaje efectivo. Niños como Alejandro, afectados por experiencias de abuso, pueden ser especialmente sensibles a estas señales (Perry y Szalavitz, 2017). Para contrarrestar esta situación, es recomendable adoptar gestos y posturas que comuniquen respeto, empatía y confianza. Esto se puede lograr manteniendo el nivel de altura similar al del niño, estableciendo un contacto visual directo, pero no intrusivo, mostrando una expresión facial amable y serena, y utilizando un tono de voz suave y tranquilo. Al utilizar un lenguaje no verbal positivo y respetuoso, podemos crear un ambiente seguro en el que Alejandro se sienta cómodo para expresarse y compartir sus emociones. Esto puede ayudarlo a sentirse más seguro, confiado y apoyado, lo que es esencial para su proceso de recuperación.

En el ámbito de la educación infantil, el uso del juego es una estrategia muy eficaz para promover un entorno tranquilo y seguro. Este enfoque aprovecha la naturaleza lúdica y receptiva de los niños, involucrando aspectos motores, cognitivos, psicoafectivos y culturales, lo que facilita un ambiente propicio para el aprendizaje y el desarrollo emocional (Piaget, 1978). La dinámica que tenía la profesora Clara y la escuela estaba basada por juegos por rincones donde en cada espacio se trabaja diferentes actividades de aprendizaje como el rincón literario, el rincón de juego simbólico, el rincón de las matemáticas o el rincón de arte. Sin embargo, sabiendo las necesidades del alumnado que se presentaban en el aula, además de Alejandro, y que la ley y profesionales reconocidos como Rafael Bisquerra (2005) consideran que es necesario trabajar las emociones en los niños, es recomendable implementar un rincón de la calma. En este espacio, se pueden abordar aspectos fundamentales del desarrollo socioemocional de los

niños, como la conciencia emocional, la regulación de emociones y la motivación, que son especialmente relevantes para Alejandro. A través de actividades diseñadas específicamente para promover estas habilidades, Alejandro puede aprender a identificar y comprender sus emociones, así como a gestionarlas de manera adecuada. Esto le proporcionará herramientas importantes para interactuar de manera más efectiva con su entorno y mejorar su bienestar emocional en general. En este rincón, se pueden aplicar técnicas de *mindfulness* para reducir el estrés, como el "masaje en círculos", meditación guiada y "piensa despacito" para mejorar la atención y expresión. Además, se pueden incorporar actividades guiadas divertidas como el yoga, según las propuestas de la Junta de Andalucía para el aula. Por otro lado, respecto al ámbito académico, si Alejandro muestra agitación a la hora de trabajar las actividades que implica estar sentados, se le puede sugerir trasladarse al área de calma para realizarlas hasta que se sienta seguro para regresar, ya que, en ocasiones, la rigidez de Alejandro hacia las actividades más “tradicionales" afectaba a su disposición para aprender. El movimiento físico y un ambiente sereno pueden contribuir a mejorar su comportamiento y facilitar un proceso de aprendizaje más efectivo y positivo.

La omisión del colegio respecto a este caso de violencia doméstica es muy grave, pues está legalmente obligado a actuar según lo establecido en la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. En su artículo 27, apartado 3, se destaca la competencia y responsabilidad exclusiva de adoptar medidas de seguridad para proteger a los menores bajo su tutela. Tanto la profesora Clara como el equipo directivo deben denunciar el caso y activar el protocolo de intervención correspondiente, que incluye la evaluación de la situación y la notificación a las autoridades competentes a través de los servicios locales o línea directa, así como ofrecer apoyo a la familia afectada (Consejería de Educación, 2024). A pesar de los intentos de Clara por proteger a Alejandro e involucrar a la familia en el proceso de intervención, sus esfuerzos no tuvieron éxito puesto que sugirió la intervención psicológica para Alejandro y eso enfureció al padre. Clara desconocía la existencia de protocolos educativos públicos para la detección temprana de necesidades especiales y la formación del personal. Recursos

como las guías de actuación de la Junta de Andalucía (2015), plataformas de la Comunidad de Madrid, LOCALIZAsalud, webgrafías como orientaciónandujar (2011) y familiaycole (2011), que tienen un apartado de actividades y recursos dedicados a la competencia emocional y acción tutorial y guías como de acción tutorial elaborado por la Junta de Extremadura (2019) que pone a disposición un dossier de 54 páginas abarcando edades de 3-16 años (*véase anexo 1 para más profundidad*).

Gracias a este caso, se llega a la conclusión de que brindar al personal docente la capacitación ante estas situaciones es muy importante. El caso de Alejandro subraya la complejidad que enfrentan los docentes al lidiar con problemas de conducta que pueden ser indicativos de situaciones traumáticas en el entorno familiar. El docente en estos contextos no solo debe abordar los aspectos académicos, sino también las necesidades emocionales y psicológicas del niño, brindando un entorno seguro y de confianza donde puedan expresar sus preocupaciones y recibir la ayuda necesaria. Es esencial que las instituciones educativas cuenten con los recursos y el apoyo necesario para abordar estas situaciones de manera efectiva, trabajando en colaboración con otros profesionales y organismos especializados en la protección y el bienestar infantil.

V. CONCLUSIONES Y DISCUSIONES.

Una infancia libre de traumas es fundamental para un desarrollo integral y saludable de los niños. En este sentido, proteger y apoyar a aquellos que han vivido situaciones traumáticas es esencial para su bienestar y crecimiento. La tarea de facilitar la recuperación de un niño que ha experimentado situaciones estresantes no resulta sencilla pues reconstruir su confianza y fomentar una visión más optimista representa todo un desafío.

La escuela se convierte en un verdadero faro para detectar y abordar el trauma en los niños. En primer lugar, los niños pasan una cantidad significativa de su tiempo en la escuela, lo que proporciona a los profesores y al personal escolar la oportunidad de observar su comportamiento y estado emocional de manera regular. Además, al tratarse de un espacio de interacción continua entre los niños y adultos, resulta sencillo valorar y observar los patrones de socialización, el desempeño académico y el nivel de motivación para participar y aprender. Cualquier aspecto que pueda sentirse diferente, podría indicar la presencia de un problema subyacente que podría estar afectando negativamente el proceso de aprendizaje del alumno.

La educación implica un compromiso continuo del docente, quien debe mantenerse actualizado y adaptarse a las necesidades sociales que rige el país. Más allá de la carrera universitaria, la formación del profesorado es un viaje constante de crecimiento profesional. Esta dedicación enriquece el proceso educativo, asegurando una enseñanza equitativa y de calidad para todos los estudiantes. Cuando hablamos del trauma, hablamos sobre como las personas que han experimentado alguna vez un evento traumático llegan a manifestar una amplia gama de sentimientos y emociones negativas. Para ayudar a los estudiantes a gestionar de manera más efectiva las secuelas del trauma, los profesores pueden aprovechar el entorno seguro del aula y corregir los comportamientos que dificultan el aprendizaje. Sin embargo, esto requiere una formación adecuada del docente y una estrecha colaboración entre la familia y la escuela. La comunicación recíproca entre ambos ámbitos proporciona la información necesaria para intervenir al alumno, identificar las causas del

problema y brindar recursos a la familia. Al implementar estas medidas en el aula, se contribuye a que el manejo del trauma sea más saludable y se pueda mitigar las consecuencias para así contribuir a que el alumno consiga explotar todo su potencial.

Realizando el trabajo, he observado la disparidad existente en las fuentes de investigación que existen entre países que dedican un considerable financiamiento en I+D y los que no. España enfrenta restricciones financieras y culturales que limitan los recursos dedicados a la investigación en salud mental, orientándolos a otras áreas. La búsqueda de información centrada en el contexto social de España ha sido complicada ya que se debe considerar los posibles sesgos al interpretar y aplicar los datos de los países extranjeros. Estos datos no son completamente objetivos y reflejan las normas y contextos específicos del país. Aunque buscar información en otro país puede enriquecer la comprensión de un tema, es vital adaptar y contextualizar los hallazgos a las realidades locales, permitiendo una aplicación más efectiva y relevante de la información.

Mantener una postura crítica respecto a las fuentes y ser conscientes de estos sesgos es esencial para los profesionales de la salud y la educación. Esto implica utilizar las investigaciones como guía y completarse con una evaluación y comprensión profunda del contexto individual de cada niño y buscar múltiples perspectivas en el diagnóstico y tratamiento del trauma. Reflexionar sobre estas cuestiones es fundamental para asegurar que las intervenciones sean verdaderamente efectivas y respetuosas con la singularidad de cada niño, evitando el daño que puede causar un enfoque demasiado rígido o superficial. A través de la integración de técnicas de apoyo emocional y actividades lúdicas en el currículo escolar, se puede fomentar la resiliencia y el bienestar de los estudiantes, transformando el sistema educativo en un pilar fundamental en la superación del trauma infantil.

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

Alderson-Day, B. y Fernyhough, C. (2015). Inner speech: Development, cognitive functions, phenomenology, and neurobiology. *Psychological Bulletin, 141*(5), 931–965. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4538954/

Alvarez J. C., Guillén, F., Portella, E. y Torres, N. (2008). *Los problemas de salud infantil. Tendencias en los países desarrollados.* Esplugues de Llobregat: Hospital Sant Joan de Déu. https://issuu.com/hospitalsantjoandedeu/docs/primer_informe_faros_cast

American Psychiatric Association (APA). (2014). *Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-5)* (5ª ed.). Editorial Médica Panamericana.

American Psychological Association (APA). (2010). *Guía de resiliencia: para padres y maestros.* https://www.apa.org/topics/resilience/guia

American Psychological Association (APA). (2011). *Camino a la resiliencia.* https://www.apa.org/topics/resilience/camino

American Psychological Association. (s.f.). Trauma. Recuperado 20 de mayo de 2024, de https://www.apa.org/topics/trauma

Andújar, A. J. (2011). *Orientación Andújar - Recursos Educativos.* Orientación Andujar. https://www.orientacionandujar.es/?s=emociones

Anton B. S. (2015). Rebounding from trauma. *American Psychological Association, 46* (6), 5. https://www.apa.org/monitor/2015/06/pc

Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). (1948). *Declaración Universal de Derechos Humanos*. Art. 26. https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/

Baars, B. (2003). Cómo el cerebro revela la mente. Los estudios neuronales respaldan el papel fundamental de la experiencia consciente. *Revista de estudios de la conciencia, 10*, 9-10.

Benito, A., Oudda L., Benito, G., Lahera, G. y Fernández, A. (2010). Los factores de resiliencia ante las situaciones traumáticas. Análisis tras los atentados del 11 de marzo en una muestra de pacientes en el CSM de Alcalá de Henares. *Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, 30* (3), 375-391. http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0211-57352010000300002&lng=es&tlng=es.

Berlinerblau, V. (2017). *Abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes Una guía para tomar acciones y proteger sus derechos*. Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF). https://www.unicef.org/argentina/sites/unicef.org.argentina/files/2018-04/proteccion-AbusoSexual_contra_NNyA-2016.pdf

Bisquerra, R. (2005). La educación emocional en la formación del profesorado. *Revista interuniversitaria de Formación del Profesorado*, *19* (3), 95-114.

Blakemore, S, J. y Frith, U. (2007). *Cómo aprende el cerebro. Las claves para la educación.* (1ª ed.). Editorial Ariel, S.A. (Trad. J. Soler).

Bowlby, J. (1969). *Attachment and loss: Attachment.* (Vol.1). Editorial Basic Books.

Bowlby, J. (1979). *The making and breaking of affectional Bonds.* (1ª ed.). Editorial Routledge.

Brady K. T. y Back S. E. (2012). Childhood trauma, Posttraumatic Stress Disorder, and Alcohol Dependence: *Alcohol Res, 34*(4), 408-13. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3860395/

Castiblanco, J. A. y Lora. M. (2008). Potenciación de pautas parentales resilientes de familias con hijos adolescentes. *Revista Tendencias & Retos,* (13), 39-54.

Cawson, P., Wattam, C., Brooker, S. y Kelly, G. (2000). *Child maltreatment in the UK: A study of the prevalence of child abuse and neglect*. National Society for the Prevention of Cruelty to Children.

Comunidad de Madrid. (s.f). *La Educación Infantil en la Comunidad de Madrid.* https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/educacion-infantil-comunidad-madrid

Comunidad de Madrid. (s.f.). *Ponemos en marcha un programa de educación socioemocional pionero en España. Think Equal*. (2021). https://www.comunidad.madrid/noticias/2021/06/13/ponemos-marcha-programa-educacion-socioemocional-pionero-espana

Consejería de Educación, Ciencia y Universidades. (2024). *Prevención ante una situación de posible riesgo, sospecha o evidencia de violencia en alumnos de los centros educativos no universitarios. Pautas para la elaboración de planes individualizados con el alumnado.* EducaMadrid. https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/651e7e61-c86f-49dd-9daf-a173969aefb7/2024-03-12%20Protocolo%20MALTRATO.pdf?t=1710236828949

Coronado, J. M. (2018). El estrés crónico y su relación con el acortamiento de telómeros y el envejecimiento prematuro. *PublicacionesDidacticas,* (97) 219-245. https://core.ac.uk/outputs/235852227/?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1

EDUCAbase. (2022). *Alumno matriculado en Educación Infantil por titularidad, comunidad autónoma/provincia, sexo y ciclo. Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.* https://estadisticas.educacion.gob.es/EducaJaxiPx/Tabla.htm?path=/no-universitaria/alumnado/matriculado/2022-2023-rd/gen-infantil/l0/&file=infantil_01.px&L=0

Erikson, E. H. (1998). *El ciclo vital completado*. (1ª ed.). Editorial Paidós Mexicana, S.A. (Trad. E. Prieto). https://www.academia.edu/38779034/Erikson_El_Ciclo_Vital_Completado_pdf

Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development. *(2021). Obesity and Overweight. NICHD*. Recuperado 20 de mayo de 2024, de https://www.nichd.nih.gov/health/topics/obesity

Eurydice. (2023). *Protocolos elaborados o promovidos por las administraciones educativas para atender a la diversidad del alumnado.* Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. https://www.educacionfpydeportes.gob.es/mc/redie-eurydice/sistemas-educativos/apoyo-educativo/protocolos-atencion.html#ancla00-2

Gerstenhaber, C. (2001). *El Mundo del Bebé*. Editorial Novedades Educativas, (35), 30-51. https://books.google.es/books?hl=es&lr=lang_en&id=IlYCjKOkYosC&oi=fnd&pg=PA30&dq=teor%C3%ADa+del+apego+bowlby+pdf&ots=3SaQqwyYIU&sig=4Fvs7Yosa4yG2aWi0peenAfSxHM#v=onepage&q=innata&f=false

Gobierno de España. (s.f.). *Separación y divorcio*. Administración.gob.es. Gobierno de España. https://administracion.gob.es/pag_Home/Tu-espacio-europeo/derechos-obligaciones/ciudadanos/familia/pareja/separacion-divorcio.html#:~:text=El%20divorcio%20es%20una%20forma,A%20petici%C3%B3n%20de%20ambos

Griffin, A. (2018). *Interventions.* The National Child Traumatic Stress Network. https://www.nctsn.org/what-is-child-trauma/trauma-types/traumatic-grief/interventions

Healthy Children.Org. (2022). Child Abuse and Neglect: What Parents Should Know. Recuperado 20 de mayo de 2024, de https://www.healthychildren.org/English/safety-prevention/at-home/Pages/Whatto-Know-about-Child-Abuse.aspx

Helping Traumatized Children Learn. (2019). *Trauma-sensitive schools help children feel safe to learn.* Traumasensitiveschools. https://traumasensitiveschools.org/trauma-and-learning/the-solution-trauma-sensitive-schools/

Interpol. (s.f.). *Terrorismo.* Interpol. https://www.interpol.int/es/Delitos/Terrorismo

Jarque, J. (2011). *Familia y Cole - Portal educativo para familias, educadores y profesionales.* Familia y cole. Recuperado 20 de mayo de 2024, de https://familiaycole.com/

Junta de Andalucía. (2015). *Protocolos de actuación en caso de.* Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional *https://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/29011941/helvia/sitio/upload/r_PROTOCOLO_DE_ACTUACIONES_EN_CASO_DE.....pdf*

Junta de Andalucía. (s.f.). *Propuesta de actividades mindfulness para el aula.* Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/documents/23723262/23768248/Propuesta+de+actividades/0b44db84-5549-8f61-96f9-7227e646b123?version=1.0

Junta de Extremadura. (2019). *Guía de acción tutorial para la promoción de la salud mental en el ámbito educativo.* https://saludextremadura.ses.es/filescms/smex/uploaded_files/CustomContentResources/GUIA_OBJETIVO_49_PROMOCION_SALUD_MENTAL_EN_EL_%20AMBITO_EDUCATIVO.pdf

Kimber, M. y MacMillan, H. L. (2017). Child Psychological Abuse. *Pediatrics In Review, 38*(10), 496-498. https://doi.org/10.1542/pir.2016-0224

Ley 6/2023, de 22 de marzo, de las personas con problemas de salud mental y sus familias. *Boletín Oficial del Estado*, *96*, 22 de abril de 2023. https://www.boe.es/eli/es-ri/l/2023/03/22/6

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. *Boletín Oficial del Estado*, *294*, de 6 de diciembre de 2018. https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3/con

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Art. 19, y 124. *Boletín Oficial del Estado, 340*, de 30 de diciembre de 2020. https://www.boe.es/eli/es/lo/2020/12/29/3

Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Art. 5, 27 y 34. *Boletín Oficial del Estado, 134,* 5 de mayo de 2021. https://www.boe.es/eli/es/lo/2021/06/04/8/con

London, S., Quinn, K., Scheidell, J. D., Frueh, B. C. y Khan, M. R. (2017). Adverse Experiences in Childhood and Sexually Transmitted Infection Risk From Adolescence Into Adulthood. *Sexually transmitted diseases*, *44* (9), 524–532. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5942895/

Lopes, S., Hallak, J. E. C., Machado de Sousa, J. P. y Osório, F. L. (2020). Adverse childhood experiences and chronic lung diseases in adulthood: a systematic review and meta-analysis. *European journal of psychotraumatology*, *11*(1). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7034480/

Marrone, M. (2009). *La teoría del apego. Un enfoque actual.* (1ª ed.). Editorial Psimática.

Matey, P. (2001). *Muchos niños para el diván.* El mundo. https://www.elmundo.es/elmundosalud/suplemento/2001/420/980928816.html

Mehrabian, A. y Wiener, M. (1967). Decoding of Inconsistent Communications. *Journal of Personality and Social Psychology*, *6* (1), 109–114.

Ministerio de Educación y Formación Profesional. (2022). Datos y cifras Curso escolar 2022/2023. Tasa neta de escolarización desde los 3 años al comienzo de la escolaridad obligatoria en educación primaria. Países Unión Europea. Curso 2019-20. https://www.educacionfpydeportes.gob.es/dam/jcr:23ffe4f5-a212-4f99-aea4-dd1baac84bd4/datos-y-cifras-2022-2023-espanol.pdf

Ministerio de Educación y Formación Profesional. (2023). *Sistema educativo en España: Curso 2022-2023.* https://www.educacionfpydeportes.gob.es/dam/jcr:ccb7accd-fb78-4bf4-bb77-691f47e658f3/sis-edu-2022-2023.pdf

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. (2015). *Las relaciones entre familia y escuela. Experiencias y buenas prácticas.* https://www.educacionfpydeportes.gob.es/dam/jcr:290c0561-c44e-493f-8aba-776114a84d2a/23encuentroconsejosescolares-pdf.pdf

Ministerio de Sanidad y Consumo. (2003). *Violencia doméstica.* https://www.sanidad.gob.es/ca/ciudadanos/violencia/docs/VIOLENCIA_DOMESTICA.pdf

Ministerio de Sanidad. *(2017). Riesgo de mala salud mental en población infantil por sexo y grupo de edad.* Portal Estadístico. Encuesta Europea de Salud en España. *https://pestadistico.inteligenciadegestion.sanidad.gob.es/publicoSNS/I/ense/serie-historica/i/salud-mental/riesgo-de-mala-salud-mental-en-poblacion-infantil/sexo-y-grupo-de-edad*

Ministerio de Sanidad. (s.f.) *Localiza salud. Mapa de recursos para la salud.* https://localizasalud.sanidad.gob.es/maparecursos/main/.action

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). (s.f.) Desastres naturales y tecnológicos contexto y concepto (pp. 272-287). *Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.* https://www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/publicaciones/DESASTRES%20NATURALES%20Y%20TECNOLOGICOS_tcm30-185233.pdf

Moneta, M. E. (2014). Apego y pérdida: Redescubriendo a John Bowlby. *Revista chilena de pediatría*, *85* (3), 265-268. https://doi.org/10.4067/S0370-41062014000300001

Oficina De las Naciones Unidad contra la Droga y el Delito (UNODC). (s.f.). *¿Qué es la discriminación racial?* [Folleto]. https://www.unodc.org/lpomex/uploads/documents/Publicaciones/Prevencion-del-delito-y-justicia-penal/UNODC-UNAM-CONAPRED-COPRED_-_Discriminacion_racial.pdf

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). (2014). *Poner fin a la violencia en la escuela: guía para los docentes.* UNESCO Digital Library. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000184162_spa

Organización Mundial de la Salud (OMS). (1948). *Constitución de la Organización Mundial de la Salud.* https://www.who.int/es/about/accountability/governance/constitution

Organización Mundial de la Salud (OMS). (2022). Informe mundial sobre salud mental: transformar la salud mental para todos. Panorama general. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/356118/9789240051966-spa.pdf?sequence=1

Organización Mundial de la Salud (OMS). (s.f.). *International Classification of Diseases (CIE-11)*. Recuperado 20 de mayo de 2024, de https://www.who.int/es/standards/classifications/classification-of-diseases

Pantoja, A. (2005). *La gestión de conflictos en el aula. Factores determinantes y propuestas de intervención*. Ministerio de Educación y Ciencia. https://www4.ujaen.es/~apantoja/mis_libros/gestion_confli_05.pdf

Perry, B. y Szalavitz, M. (2017). *El chico que criaron como perro: y otras historias del cuaderno de un psiquiatra infantil.* Editorial Capitán Swing Libros, S.L. (Trad. Barahona).

Peterson, S. (2018). *About child trauma.* The National Child Traumatic Stress Network. https://www.nctsn.org/what-is-child-trauma/about-child-trauma

Piaget, J. (1926). *The language and thought of the child*. (1ª ed.). Editorial Routledge.

Piaget, J. (1978). *La Formación del Símbolo en el niño.* Editorial Fondo de Cultura Económica.

Real Academia Española. (s.f.). Trauma. *Diccionario de la lengua española*. Edición del Tricentenario. Recuperado 20 de mayo de 2024, de https://dle.rae.es/trauma

Roberts, M. E., Fuemmeler, B. F., McClernon, F. J. y Beckham, J. C. (2008). Association between trauma exposure and smoking in a population-based sample of young adults. *The Journal of adolescent health: official publication of the Society for Adolescent Medicine*, *42*(3), 266–274. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2675188/

Rutledge, T. (2022). *El impacto del trauma en el corazón.* Psychology Today. Recuperado 20 de mayo de 2024, de https://www.psychologytoday.com/es/blog/el-impacto-del-trauma-en-el-corazon

Shvets. A. (2021). La nueva pandemia psicológica. *Consejo General de Psicología en España (INFOCOP).* https://www.infocop.es/la-nueva-pandemia-psicologica/

Sroufe, A., Egeland, B., Carlson, E. y Collins, A. (2007). The Development of the Person: The Minnesota Study of Risk and Adaptation from Birth to Adulthood. *Journal of the Canadian Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, *16*(4), 180–181.

U.S. Department of Veterans Affairs. (s.f.). *PTSD Basics.* https://www.ptsd.va.gov/spanish/understand/what/ptsd_basics_sp.asp

United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF). (2009). *Las escuelas como entornos protectores. Escuelas amigas de la infancia.* 125-160. https://www.unicef.org/venezuela/media/726/file/Escuelas%20amigas%20de%20la%20Infancia.pdf

Van Der Kolk, B. (2015). *El cuerpo lleva la cuenta: Cerebro, mente y cuerpo en la superación del trauma*. (1ª ed). Editorial Eleftheria, S. L. (Trad. M. Foz).

Vygotski, L. S. (1979) *El desarrollo de los procesos psicológicos superiores*. (2ª ed.). Editorial KnitoitiAi Crítica, S.L. https://www.fre.uy/a/cb9c5ac3/vigotskiLIBROCOMPLETO-el-desarrollo-de-los-procesos-psicologicos-superioresSINCOPYRIGHT.pdf

VII. ANEXOS.

ANEXO 1.

Acciones y organizaciones en España: recursos y organizaciones para apoyo en situaciones de trauma infantil en España.

En España, residen alrededor de 8 millones de niños y adolescentes, quienes poseen derechos plenos desde que nuestro país firmó, aceptó y asistió a la Convención de las sobre los Derechos del Niño (CND) en 1990. Desde entonces, se han alcanzado importantes avances en la promoción, protección y garantía de los derechos de los niños. Esta convención, que consta de 54 artículos, abarca derechos económicos, sociales, civiles y políticos que ayudan a mitigar situaciones traumáticas, como la prostitución infantil y la participación de niños en conflictos armados, entre otros.

En 2021, gracia a la incorporación del primer Consejo Estatal de Participación de la Infancia y la Adolescencia (CEPIA) (Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, 2023) y la protección a la infancia realizado por el gobierno de España se brindó atención a 48.357 niños, registrando descensos en años anteriores (49.171 en 2020 y 50.272 en 2019). Las tutelas descendieron de 31.738 a 29.910, y las guardas de 3.870 a 3.280, mientras que los acogimientos residenciales disminuyeron de 23.209 en 2019 a 16.177 en 2021. En la Comunidad de Madrid, a pesar de ser la tercera en la lista con más menores atendidos, solo se atendió un total de 5.841, incluyendo 3.184 bajo tutela “ex lege”, regulada por la ley 1/1996 de Protección Jurídica del Menor (Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, 2023).

El ministerio de Sanidad de España (2023) ofrece una serie de recursos para promoción de la salud y la prevención frente a casos de violencia en la infancia y adolescencia. Los cuales se dividen en:

Organismos nacionales.

Estatales:

Protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Presidencia del Gobierno: Se trata de una nueva Ley que aborda diversas medidas en múltiples ámbitos, incluyendo educación, apoyo familiar, servicios sociales y justicia, en consonancia con estándares internacionales y la Agenda 2030. Su enfoque principal es establecer un paradigma de prevención y protección contra la violencia hacia la infancia y adolescencia. (Consejo de ministros, 2020).

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030: Es un organismo del Gobierno de España encargado de proteger y promover los derechos sociales de la ciudadanía, así como de impulsar el cumplimiento de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Es un departamento clave para promover el bienestar de la ciudadanía española y cumplir los compromisos internaciones en materia de derechos sociales y desarrollo sostenible.

Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia: Es un órgano de cooperación entre la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y la Administración Local, con sede en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Su objetivo es coordinar políticas para proteger y desarrollar los derechos de la infancia y la adolescencia.

El Consejo Estatal de Participación de la Infancia: Es un órgano dependiente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 creado en 2021 que facilita la participación de niños de 8 a 17 años en la creación de estrategias para combatir la violencia infantil. Su labor incluye elaborar protocolos de prevención, detección y actuación ante episodios de violencia, así como contribuir a la formulación de la Estrategia Estatal de Derechos de la Infancia y la Adolescencia hasta 2030, entre otras consultas.

Observatorio de la infancia: Al igual que el Consejo Estatal de Participación de la Infancia es un órgano adscrito al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. En este caso su campo se centra más en la elaboración de estudios e informes creados por expertos profesiones y representantes de la sociedad cuya función

es analizar la situación de la infancia y promover políticas públicas hacia el menor.

Entidades sociales a nivel Nacional:

Fundación ANAR: La Fundación ANAR, fundada en 1970 es una organización no gubernamental sin fines de lucro, se dedica a salvaguardar los derechos de la infancia y adolescencia en España. Proporciona una variedad de servicios como el Teléfono ANAR de Ayuda, atención psicológica, programas preventivos, formación, así como investigación y estudios. Es ampliamente reconocida por su destacada labor en la promoción de los derechos infantiles.

Asociación de Ayuda Mutua Adversidad Temprana y Apego: La Asociación Petales España es una asociación sin ánimo de lucro que ofrece apoyo y ayuda a familias y personas afectadas por trastornos del desarrollo y del vínculo afectivo o apego.

Entidades sociales a nivel internacional con sede en España:

Educo: Se trata de una ONG internacional, que enfoca sus esfuerzos en garantizar el derecho a una educación de calidad para la infancia. En España desde 1996, proporciona becas, construye escuelas, capacita docentes, implementa programas educativos y aboga por políticas inclusivas. También ofrece análisis sobre crisis internacionales como las guerras en Ucrania y Gaza o el terremoto de Marruecos. Su labor es ampliamente reconocida por el impacto positivo que genera en la vida de niños y familias.

Save the children y UNICEF España: Tanto Save the Children como UNICEF son organizaciones no gubernamentales con alcance internacional, al igual que Educo. Save the Children se dedica a combatir la pobreza infantil y brindar atención en situaciones de emergencia, como conflictos armados o desastres naturales, a través de programas propios y sensibilización social. Por otro lado, UNICEF trabaja para garantizar que todos los niños, incluso los más vulnerables, tengan igualdad de derechos, colaborando con gobiernos, instituciones y programas de investigación.

Recursos promovidos por el gobierno de España.

Protocolos elaborados o promovidos por las administraciones educativas para atender la diversidad del alumnado: La red institucional de la Unión Europea, Eurydice, recopila y difunde información sobre sistemas educativos europeos. En España, desde 1987, se promueven protocolos para la detección temprana de necesidades educativas especiales, abarcando identificación, actuación y formación del personal educativo. Estos protocolos incluyen la identificación de situaciones y señales de alerta, actuación multidisciplinar, y formación y seguimiento del personal educativo.

Protocolos de actuación de la junta de Andalucía: Se presenta una guía exhaustiva que detalla características, síntomas y protocolos de intervención paso a paso en casos de acoso, maltrato, *bullying* y violencia en el ámbito educativo. Aunque no pertenece a la Comunidad de Madrid, puede servir como referencia para evaluar el contexto y establecer líneas de actuación, siempre sujeto a la autorización de la institución educativa.

Consejos de Atención a la infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid: Dentro de la Comunidad de Madrid, se ha establecido una plataforma en línea destinada a mejorar la convivencia y el clima social en los centros educativos. Esta plataforma ofrece una variedad de recursos, herramientas y actividades diseñadas para promover la salud y el bienestar emocional. Entre estos recursos se incluyen unidades didácticas, materiales para el aula, orientación para profesores, alumnos y familias.

Guía de acción tutorial para la promoción de la salud mental en el ámbito educativo: El presente documento, elaborado por la Junta de Extremadura, se dirige principalmente a los docentes, aunque muchas de las actividades pueden ser realizadas en el hogar por los padres. Consiste en un dossier de 54 actividades divididas por edades, abarcando desde los 3 hasta los 16 años. Estas actividades se centran en el desarrollo de habilidades emocionales, como la regulación emocional, la tolerancia, la afectividad interpersonal y la exploración del autoconcepto y la autoestima.

LOCALIZAsalud: Es una aplicación informática diseñada para facilitar la visualización de recursos y actividades que promueven la salud y el bienestar en los municipios adheridos a la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud (SNS). En este buscador podrás filtrar por actividad, edad, necesidades, municipio y gratuidad. Es una herramienta altamente beneficiosa para localizar talleres, recursos y profesionales especializados en el área de interés que estás buscando.

Recursos y webgrafías para docentes y padres.

Familiaycole.com: Se trata de una página web desarrollada por el pedagogo Jesús Jarque en 2011, que ofrece actividades y recursos dirigidos a niños de 2 a 12 años. En esta plataforma, los usuarios pueden encontrar materiales, folletos para padres, orientaciones profesionales y pautas para diversas necesidades educativas. Para acceder a las actividades relacionadas con las emociones, se recomienda realizar una búsqueda en el buscador utilizando la palabra clave "emociones".

Orientacionandujar.com: Es una página elaborada por Ginés y Maribel donde brinda recursos educativos digitales principalmente al personal docente o personal educativo. Si bien ofrece una variedad de secciones se puede acceder a las actividades relacionadas con las emociones buscando en el buscador “emociones” como palabra clave.

Recursos a nivel internacional para docentes, padres y otros profesionales.

NCTSN: Dentro de la página oficial del NCTSN se encuentra una página con diferentes ítems para buscar diferentes recursos de apoyos y materiales específicos para trabajar las experiencias traumáticas. Esta información está destinada a la formación, capacitación y exploración sobre el trauma en diversos ámbitos y diferentes edades. Dentro de la misma se encuentran folletos informativos tanto en español como en inglés para ayudar al afectado desde diferentes líneas de actuación ya sea dentro de la escuela o fuera de la escuela.

Caja de herramientas para educadores y familia:

https://www.nctsn.org/sites/default/files/resources/child_trauma_toolkit_educators_sp.pdf

Primeros auxilios psicológicos para profesores:
https://www.nctsn.org/sites/default/files/resources/fact-sheet/pfa_for_schools_for_teachers.pdf

UNESCO: Dentro de la UNESCO Digital Library se encuentra un documento titulado "guía para docentes sobre la violencia". En el Anexo 2, apartado "poner fin a la violencia en la escuela: enlaces a información en línea", se proporcionan una serie de enlaces externos en inglés que ofrecen materiales didácticos de calidad, cursos para el profesorado y actualizaciones sobre iniciativas relacionadas con la temática abordada. Si bien algunos de los son externos a la UNESCO algunos proporcionan información interesante como “Etwinning”, una página oficial de la Unión Europea cuya misión es compartir una visión inclusiva dentro de las escuelas ya sea a través de recursos, publicaciones o materiales o páginas oficiales de UNICEF que ofrece información sobre la protección infantil y añade enlaces a recursos tanto para estudiantes como para docentes.

Child Mind Institute: Ofrece recursos y guía sobre diferentes problemas de salud mental que nos podemos encontrar en el aula. Entre ellos, se encuentra un apartado dedicado al trauma y cómo trabajarlo.

BIBLIOGRAFÍA Y ENLACES DE INTERÉS DE LOS ANEXOS.

Andújar, A. J. (2011). *Orientación Andújar - Recursos Educativos*. Orientación Andujar. Recuperado el 20 de mayo de 2024, de https://www.orientacionandujar.es/?s=emociones

Child Mind Institute. (s.f.). *Recursos para educadores - Child Mind Institute.* Recuperado el 20 de mayo de 2024, de https://childmind.org/es/temas/recursos-para-educadores/

Comunidad de Madrid. (s.f.). *Recursos para la elaboración de programas contra el acoso escolar.* Educa Madrid. Recuperado el 20 de mayo de 2024, de https://www.educa2.madrid.org/web/convivencia/recursos-a-nivel-de-centro

Consejo de ministros. (2020). *Protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.* La moncloa. Recuperado el 20 de mayo de 2024 de, *https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/090620-enlace_infancia.aspx*

Educo. (s.f.). *Educo - ONG de Cooperación Internacional por la Infancia.* Recuperado el 20 de mayo de 2024 de https://www.educo.org/buscar/busquedaporindice?textoBusqueda=trauma

Eurydice. (2023) Protocolos elaborados o promovidos por las administraciones educativas para atender a la diversidad del alumnado. *Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.* https://www.educacionfpydeportes.gob.es/mc/redie-eurydice/sistemas-educativos/apoyo-educativo/protocolos-atencion.html#ancla00-2

Fundación ANAR. (s.f.). *Fundación ANAR - Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo.* Recuperado el 20 de mayo de 2024 de https://www.anar.org/

Instrumento de Ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. *313*, 31 de diciembre de 1990. https://www.boe.es/eli/es/ai/1989/11/20/(1)

Jarque, J. (2011). *Familia y Cole - Portal educativo para familias, educadores y profesionales.* Familia y cole. https://familiaycole.com/

Junta de Extremadura. (2019). *Guía de acción tutorial para la promoción de la salud mental en el ámbito educativo.* https://saludextremadura.ses.es/filescms/smex/uploaded_files/CustomContentResources/GUIA_OBJETIVO_49_PROMOCION_SALUD_MENTAL_EN_EL_%20AMBITO_EDUCATIVO.pdf

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. (2023). Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia y la adolescencia. https://www.mdsocialesa2030.gob.es/derechos-sociales/infancia-y-adolescencia/PDF/Estadisticaboletineslegislacion/BOLETIN_Proteccion_ANO_2021_ACCESIBLE.pdf

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. (s.f.). Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. Recuperado el 20 de mayo de 2024 de https://www.mdsocialesa2030.gob.es/derechos-sociales/infancia-y-adolescencia/Conferencia_Sectorial_InfanciayAdolescencia.htm

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. (s.f.). *Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.* Recuperado el 20 de mayo de 2024 de https://www.mdsocialesa2030.gob.es/

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. (s.f.). *Observatorio de la Infancia.* Recuperado el 20 de mayo de 2024 de https://observatoriodelainfancia.mdsocialesa2030.gob.es/queEs/home.htm

Ministerio de Sanidad. (2023). *Enlaces de interés.* Recuperado el 20 de mayo de 2024 de, https://www.sanidad.gob.es/areas/promocionPrevencion/prevencionViolencia/infanciaAdolescencia/enlacesDeInteres.htm

Ministerio de Sanidad. (s.f.). *Localiza salud. Mapa de recursos para la salud.* https://localizasalud.sanidad.gob.es/maparecursos/main/.action

The National Child Traumatic Stress Network (NCTSN). (s.f.). *The National Child Traumatic Stress Network.* Recuperado el 20 de mayo de 2024 de https://www.nctsn.org/what-is-child-trauma/trauma-types/traumatic-grief/interventions

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). (2014). *Poner fin a la violencia en la escuela: guía para los docentes.* UNESCO Digital Library. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000184162_spa

Petales España: Asociación de Ayuda Mutua Adversidad Temprana y Apego. (s.f.). PETALES España. Recuperado el 20 de mayo de 2024 de https://xn--petalesespaa-khb.org/

Save the Children. (s.f.). Página de inicio. Recuperado el 20 de mayo de 2024 de https://www.savethechildren.es/

Unicef España. (s.f.). Página de inicio. *UNICEF*. Recuperado el 20 de mayo de 2024, de https://www.unicef.es/

VIII. ABREVIACIONES.

APA = American Psychological Association.

MTI = Modelo de Trabajo Interno.

NCTSN = The National Child Traumatic Stress NetworK.

OMS = Organización Mundial de la Salud.

RAE = Real Academia Española.

TEPT = Trastorno de Estrés Post Traumático.

TFG = Trabajo Fin de Grado.

UNESCO = United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

UNICEF = United Nations Children's Fund.